



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

PEDOMAN PENGORGANISASIAN *CLEANING SERVICE*

Tahun 2025

Jl. Raya Surabaya - Malang No. KM 54, Sukorejo - Pasuruan

Telp. 0343 - 6745000

Email : sekretariat@sukorejo.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Pedoman Pengorganisasian *Cleaning Service* Rumah Sakit ini dapat disusun dengan baik. Pedoman ini disusun sebagai acuan bagi seluruh petugas *cleaning service* dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya guna menciptakan lingkungan rumah sakit yang bersih, aman, nyaman, dan mendukung upaya pencegahan serta pengendalian infeksi.

Kebersihan lingkungan rumah sakit merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Lingkungan yang bersih dan higienis tidak hanya memberikan kenyamanan bagi pasien, keluarga pasien, dan pengunjung, tetapi juga berperan penting dalam mendukung keselamatan pasien serta tenaga kesehatan. Oleh karena itu, pengorganisasian *cleaning service* harus dilaksanakan secara terencana, terstandar, dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan serta standar akreditasi rumah sakit yang berlaku.

Pedoman ini memuat berbagai aspek penting dalam penyelenggaraan pelayanan *cleaning service*, antara lain pengorganisasian, tata laksana pelayanan, pengelolaan logistik, keselamatan dan kesehatan kerja, hingga pengendalian mutu. Dengan adanya pedoman ini diharapkan seluruh petugas *cleaning service* dapat menjalankan tugasnya secara profesional, efektif, dan sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

Kami menyadari bahwa pedoman ini masih memerlukan penyempurnaan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, masukan dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan pedoman ini di masa yang akan datang.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan pedoman ini. Semoga pedoman ini dapat menjadi panduan yang bermanfaat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kebersihan lingkungan rumah sakit

Direktur Rumah Sakit Prima Husada



Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep., M.Kep.

LEMBAR PENGESAHAN

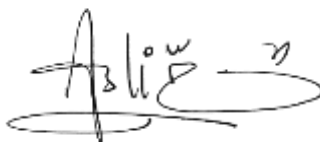
Pedoman Pengorganisasian *Cleaning Service*
Rumah Sakit Prima Husada
Tahun 2025

Disusun oleh :
Penanggung Jawab



(Andy Bagus Setiawan)

Disetujui oleh :
Authorized Person



(Dr. dr. Aslichah, M. Kes. AFP)

Ditetapkan oleh :
Direktur Rumah Sakit Prima Husada



(Heni Indra Wulansari, S.Kep., Ns., M.Kep.)

TIM PENYUSUN
PEDOMAN PELAYANAN *CLEANING SERVICE*

PENGARAH

1. Dr. dr. Aslichah, M.Kes., AFP

Pelaksana

2. Wulandari
3. Dwi Siska Hardiyanti, S.Kep., Ns
4. Andy Bagus Setiawan
5. M. Toyib Arifin
6. Erdin Kurniawan
7. Thoriqul Khakim
8. Sahrul Firmansyah
9. Achmad Syaichu
10. Iqbal Zakarzi Raharjo
11. M. Jupri
12. Didik Pramono
13. Zaki Amin
14. Roni Junaedi



**PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
NOMOR: 935.14/RSPHS/I-PER/DIR/XI/2025**

**TENTANG
PEDOMAN PENGORGANISASIAN UNIT *CLEANING SERVICE***

DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit serta menciptakan lingkungan yang bersih, aman, dan nyaman bagi pasien, pengunjung, dan petugas, diperlukan penyelenggaraan pelayanan kebersihan yang terstandar di lingkungan rumah sakit;
- b. bahwa pelayanan kebersihan lingkungan rumah sakit merupakan bagian penting dalam mendukung upaya pencegahan dan pengendalian infeksi serta keselamatan pasien;
- c. bahwa agar pelaksanaan pelayanan kebersihan oleh Unit *Cleaning Service* di Rumah Sakit dapat berjalan secara efektif, terarah, dan sesuai dengan standar akreditasi rumah sakit, perlu disusun pedoman sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Direktur Rumah Sakit tentang Pedoman Unit *Cleaning Service* Rumah Sakit
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah;
2. Undang – Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27/MENKES/PER/I/2017 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1204/MENKES/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit;
8. Keputusan Menteri Kesehatan No.HK.01.07/MENKES/1596 Tahun 2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit
9. Keputusan Direktur Utama Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor 059.1/RSPHS/I-KEP/DIR/I/2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata kerja Rumah Sakit Prima Husada;
10. Keputusan Direktorat Jendral No HK.01.07.MENKES.1596.2024 Tentang Standart Akreditasi Rumah Sakit;
11. Keputusan Direktorat Jendral No HK.02.02.D.43961.2024 Tentang Pedoman Survei Akreditasi Rumah Sakit;
12. Keputusan Direktur Utama Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor 1041.21/DPM/I-KEP/DIR/XI/2025 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Prima Husada

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
TENTANG PEDOMAN PENGORGANISASIAN *CLEANING SERVICE***

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.
- (2) *Cleaning Service* adalah petugas yang bertanggung jawab dalam menjaga kebersihan, kerapian, dan sanitasi lingkungan rumah sakit.
- (3) Kebersihan Lingkungan adalah kegiatan pembersihan, pemeliharaan, dan sanitasi seluruh area rumah sakit untuk menciptakan lingkungan yang aman dan sehat.
- (4) Unit *Cleaning Service* memiliki sistem pengorganisasian yang meliputi struktur organisasi, pembagian tugas, tanggung jawab, pola ketenagaan, kompetensi petugas, mekanisme pelaporan, koordinasi kerja, serta evaluasi pelayanan sehingga tercipta pelayanan kebersihan yang efektif, efisien, dan terstandar.

BAB II GAMBARAN UMUM RUMAH SAKIT

Pasal 2

Gambaran Umum Rumah Sakit

- (1) Sumber daya manusia pada unit *Cleaning Service* merupakan tenaga yang memiliki tanggung jawab dalam menjaga kebersihan, kerapian, dan sanitasi lingkungan rumah sakit. Untuk menjamin kualitas pelayanan kebersihan yang baik, maka petugas *Cleaning Service* harus memenuhi kualifikasi tertentu.
- (2) Struktur ketenagaan terdiri dari
 - a. Koordinator *cleaning service*
 - b. Pelaksana *cleaning service*

BAB III VISI, MISI, NILAI BUDAYA, MOTO RUMAH SAKIT

Pasal 3

Visi Rumah Sakit

“Menjadi rumah sakit berkualitas prima pilihan seluruh lapisan masyarakat”

Pasal 4

Misi Rumah Sakit

- (1) Memberi pelayanan kesehatan dengan amat, tepat, cepat dan akurat
- (2) Mengutamakan kepuasan pasien.
- (3) Meningkatkan mutu pelayanan yang berkelanjutan.

Pasal 5

7 Nilai Budi Utama

- (1) Jujur
- (2) Tanggung Jawab
- (3) Visioner
- (4) Disiplin
- (5) Kerjasama
- (6) Adil
- (7) Peduli

Pasal 6
Motto
“Sahabat Menuju Sehat”

BAB IV

STRUKTUR ORGANISASI UNIT KERJA

Pasal 7

Struktur Organisasi Cleaning Service



BAB V URAIAN JABATAN

Pasal 8 Struktur Organisasi



Pasal 9 Uraian Jabatan

- (1) Direktur bertanggung jawab memimpin dan mengendalikan seluruh penyelenggaraan pelayanan rumah sakit, menetapkan kebijakan strategis, mengelola sumber daya dan anggaran, serta memastikan terlaksananya pelayanan yang bermutu, aman, efektif, efisien, berorientasi pada keselamatan pasien, memenuhi standar akreditasi, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Bidang Umum bertanggung jawab mengelola, mengoordinasikan, dan mengawasi seluruh pelayanan penunjang umum rumah sakit, termasuk kebersihan, keamanan, laundry, transportasi, serta sarana dan prasarana, guna menjamin kelancaran operasional, kenyamanan, keamanan lingkungan, dan pemenuhan standar akreditasi serta peraturan yang berlaku. Kepala Bidang Umum juga bertanggung jawab melakukan pembinaan sumber daya manusia, pengelolaan program kerja, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan kepada Direktur Rumah Sakit.
- (3) Kepala Unit Cleaning Service bertanggung jawab mengelola, mengoordinasikan, dan mengawasi seluruh kegiatan kebersihan lingkungan rumah sakit, termasuk pengelolaan sumber daya, pelaksanaan SOP, pembinaan petugas, pemantauan mutu pelayanan, serta memastikan terpenuhinya standar kebersihan, keselamatan kerja, akreditasi, dan program PPI di lingkungan rumah sakit.
- (4) Pelaksana Cleaning Service bertanggung jawab melaksanakan pelayanan kebersihan dan desinfeksi lingkungan rumah sakit sesuai SOP, PPI, dan K3RS, menjaga kebersihan area kerja, mengelola sampah sesuai ketentuan, menggunakan APD secara benar, merawat peralatan kerja, serta mendukung terciptanya lingkungan rumah sakit yang bersih, aman, nyaman, dan bebas risiko infeksi.
- (5) Pelaksana Taman bertanggung jawab melaksanakan pemeliharaan taman dan penghijauan rumah sakit,

menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan, merawat tanaman dan fasilitas taman, menggunakan peralatan kerja sesuai prosedur keselamatan, serta mendukung terciptanya lingkungan rumah sakit yang bersih, nyaman, sehat, dan representatif.

- (6) Pelaksana Tukang Sipil bertugas melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana, prasarana, serta bangunan rumah sakit, termasuk pekerjaan sipil sederhana seperti pengecatan, perbaikan dinding, lantai, dan plafon.

BAB VI

TATA HUBUNGAN KERJA

Pasal 10



BAB VII

POLA KETENAGAAN DAN KUALIFIKASI PERSONIL

Pasal 11

Pola Ketenagaan

- (1) Kepala bagian CS
Standart Pendidikan : SMA/D3 Kesehatan/Manajemen RS
Standart sertifikasi : Pelatihan Manajemen Cleaning Service, K3 dan PPI dasar
- (2) PJ CS
Standart Pendidikan : SMA/SMK
Standart sertifikasi : Pelatihan Manajemen Cleaning Service, K3 dan PPI dasar
- (3) Anggota CS
Standart Pendidikan : SMA/SMK
Standart sertifikasi : Pelatihan K3 dan PPI dasar

BAB VIII

PROGRAM ORIENTASI

Pasal 12

Orientasi Umum

- (1) Orientasi umum rumah sakit merupakan kegiatan pengenalan bagi pegawai baru untuk memahami kebijakan, sistem kerja, serta budaya kerja di Rumah Sakit Prima Husada.
- (2) Materi orientasi umum;
 - a. Profil Rumah Sakit Prima Husada.
 - b. Visi, misi, motto, dan nilai-nilai rumah sakit.
 - c. Struktur organisasi rumah sakit.
 - d. Peraturan dan tata tertib pegawai.
 - e. Program mutu dan keselamatan pasien.
 - f. Program Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI).
 - g. Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja Rumah Sakit (K3RS).
 - h. Etika pelayanan dan komunikasi efektif.
 - i. BHD
- (3) Penilaian orientasi umum
 - a. Kehadiran peserta orientasi.
 - b. Evaluasi pemahaman materi melalui pre-test dan post-test.
 - c. Observasi sikap dan partisipasi peserta selama kegiatan orientasi.

Pasal 13

Orientasi Khusus

- (1) Orientasi unit merupakan kegiatan pengenalan bagi pegawai baru yang ditempatkan di Unit Cleaning Service agar memahami tugas, tanggung jawab, serta prosedur kerja
- (2) Materi orientasi unit
 - a. Struktur organisasi Unit Cleaning Service.
 - b. Tugas dan tanggung jawab petugas Cleaning Service.
 - c. Alur pengelolaan limbah dan kebersihan rumah sakit.
 - d. Prosedur pengambilan limbah dari unit pelayanan dan pembersihan lingkungan.
 - e. Penggunaan alat pelindung diri (APD).
 - f. Pencegahan dan pengendalian infeksi dalam pengelolaan lingkungan.
 - g. Keselamatan kerja di Unit Cleaning Service.
- (3) Jadwal orientasi unit
 - a. Dilakukan ± 1-3 hari kerja
 - b. Penilaian orientasi unit dilakuakn melalui,
 - 1) Observasi langsung oleh kepala unit Cleaning Service.
 - 2) Evaluasi pemahaman prosedur kerja.
 - 3) Kemampuan petugas dalam melaksanakan tugas sesuai SOP.

BAB XI PERTEMUAN/RAPAT

Pasal 14

- (1) Rapat rutin digolongkan menjadi dua kategori yang meliputi;

- a. Rapat koordinasi dilakukan dengan menyesuaikan jadwal direksi
 - b. Rapat satuan kerja dilakukan setiap hari Kamis di minggu kedua bulan berjalan
- (2) Rapat insidentil diselenggarakan sewaktu-waktu bila ada masalah atau sesuatu hal yang perlu dibahas segera

BAB X

PELAPORAN

Pasal 15

Pelaporan Kegiatan CS

- (1) Pelaporan kegiatan unit CS meliputi;
 - a. Laporan harian
 - b. Laporan bulanan
 - c. Laporan isidentil
- (2) Evaluasi pelaporan dilakukan secara berkala untuk menilai;
 - a. Tingkat kebersihan lingkungan Rumah Sakit;
 - b. Ketepatan dan konsistensi pelaksanaan kegiatan *cleaning service*;
 - c. Kepatuhan petugas terhadap SPO, PPI, dan K3RS;
 - d. Ketersediaan sarana, prasarana, dan bahan kebersihan;
 - e. Permasalahan yang terjadi serta tindak lanjut perbaikan.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 16

Pedoman Pengorganisasian *Cleaning Service* Rumah Sakit ini disusun sebagai acuan bagi seluruh petugas *cleaning service* dalam melaksanakan tugas kebersihan lingkungan rumah sakit secara efektif, aman, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Pasal 17

Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan,
Pada tanggal 01 November 2025
Direktur Rumah Sakit Prima Husada.



Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep., M.Kep

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA
HUSADA SUKOREJO
NOMOR 935.14/RSPHS/I-PER/DIR/XI/2025
TENTANG
PEDOMAN PENGORGANISASIAN UNIT
CLEANING SERVICE

**PEDOMAN PENGORGANISASIAN UNIT *CLEANING SERVICE*
TAHUN 2025**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar belakang

Rumah sakit merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan secara menyeluruh kepada masyarakat, sehingga kebersihan lingkungan rumah sakit menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung mutu pelayanan, keselamatan pasien, keselamatan petugas, serta pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI).

Unit *Cleaning Service* memiliki peran strategis dalam menjaga kebersihan, kerapian, kenyamanan, dan sanitasi lingkungan rumah sakit sesuai standar kesehatan lingkungan rumah sakit dan standar akreditasi rumah sakit tahun 2024. Pelaksanaan kebersihan yang baik akan membantu mencegah terjadinya *Healthcare Associated Infections* (HAIs), meningkatkan keselamatan kerja, dan menciptakan lingkungan rumah sakit yang aman dan nyaman bagi pasien, keluarga pasien, pengunjung, maupun petugas.

Dalam pelaksanaannya, Unit *Cleaning Service* harus memiliki sistem pengorganisasian yang jelas meliputi struktur organisasi, pembagian tugas, tanggung jawab, pola ketenagaan, kompetensi petugas, mekanisme pelaporan, koordinasi kerja, serta evaluasi pelayanan sehingga tercipta pelayanan kebersihan yang efektif, efisien, dan terstandar.

Berdasarkan hal tersebut, maka disusun Pedoman Pengorganisasian Unit *Cleaning Service* Rumah Sakit sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan kebersihan lingkungan rumah sakit sesuai ketentuan dan standar akreditasi rumah sakit tahun 2024.

1.2 Maksud dan Tujuan

1.2.1 Maksud

Pedoman ini disusun sebagai acuan dalam pengorganisasian dan pelaksanaan pelayanan Unit *Cleaning Service* di rumah sakit.

1.2.2 Tujuan

a. Tujuan Umum

Mewujudkan pelayanan kebersihan rumah sakit yang profesional, aman, efektif, efisien, dan sesuai standar akreditasi rumah sakit tahun 2024.

b. Tujuan Khusus

1. Menjadi pedoman kerja petugas *cleaning service*.
2. Menjelaskan struktur organisasi dan hubungan kerja unit.
3. Menetapkan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan petugas.
4. Menjamin kebersihan lingkungan rumah sakit sesuai standar PPI.
5. Menurunkan risiko infeksi akibat lingkungan yang tidak bersih.
6. Meningkatkan keselamatan pasien, pengunjung, dan petugas.
7. Meningkatkan mutu pelayanan kebersihan rumah sakit.

BAB II

GAMBARAN UMUM RUMAH SAKIT

2.1 Deskripsi RS Prima Husada

2 November 2018 berdirilah Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo (RS PHS) beralamatkan di Jalan Surabaya – Malang KM. 54 Desa Lemahbang, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.

RS PHS terletak di wilayah yang termasuk dalam tata kota perumahan atau hunian rumah dengan iklim yang sejuk karena berada di kaki Gunung Arjuno dengan letak yang sangat strategis dan lalu lintas yang cukup ramai serta dilewati berbagai macam angkutan umum. Dengan akses tempuh 15 menit dari Terminal Pandaan dan 32 menit dari Stasiun Bangil, RS PHS menawarkan konsep pelayanan kesehatan yang bisa menjawab kebutuhan kesehatan masyarakat Kabupaten Pasuruan. Masyarakat di sekitar Pasuruan menerima dengan baik kehadiran Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo.

Rumah Sakit Prima Husada berlokasi di Banjararum Selatan No 3 – 7 Mondoroko, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang 65153, Jawa Timur, Indonesia. Telp. 0341 – 458679, 458916, Fax: 0341 – 441874, email primahusadamalang@gmail.com/ info@rs-primahusada.id, website www.rs-primahusada.id.

Rumah Sakit Prima Husada adalah salah satu Rumah Sakit yang memberikan pelayanan langsung khususnya pelayanan kesehatan, dipimpin oleh seorang Direktur dan memiliki 3 Manajer yaitu Manajer Pelayanan dan Manajer Keuangan dan Akuntansi dan Manajer Umum dan di dalam tugasnya dibantu oleh Kepala Bidang dan Kepala Bagian.

Rumah Sakit Prima Husada dengan pelayanan meliputi pelayanan Instalasi Gawat Darurat, Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Kamar Operasi, Penunjang Medik, dan Penunjang Non Medik, serta Instalasi Rawat Inap yang terdiri dari kelas I, II, III, VIP dan VVIP.

Dalam upaya memberikan pelayanannya, rumah sakit dituntut memberikan pelayanan sebaik –baiknya sebagai public service. Meningkatnya tuntutan dapat dilihat dengan munculnya kritik –kritik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelayanan yang diberikan. Berkenaan dengan hal tersebut, maka Rumah Sakit Prima Husada perlu menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat terhadap peningkatan pelayanan secara bertahap melalui upaya program peningkatan mutu pelayanan rumah sakit.

2.2 Sejarah Institusi RS Prima Husada

Berawal dari Praktek pribadi dr. Sadi Hariono, MMRS sebagai dokter umum sejak tahun 1990 diBanjararum Selatan No. 3B, kami telah mengabdikan diri melayani masyarakat dengan penuh tanggung jawab. Seiring dengan perkembangan penduduk dan peningkatan kebutuhan akan pelayanan kesehatan yang lebih luas, maka kamipun berupaya mengembangkan diri untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang lebih lengkap, sehingga mengantarkan kami pada berdirinya Rumah Sakit Prima Husada.

Perjalanan Peningkatan Status Pelayanan :

Tahun 1990 – 2005 : Praktek Pribadi Dokter Umum

Tahun 2005 – 2009 : Balai Pengobatan Prima Husada

Agustus 2009 : Klinik Rawat Inap Layanan Medik Dasar

Mei 2010 : Menjadi Rumah Sakit Umum dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang

Tahun 2010 – 2014 : Izin Operasional Rumah Sakit Sementara

Februari 2015 : Izin Operasional Rumah Sakit Tetap

Februari 2016 : Penetapan Rumah Sakit Tipe C

Maret 2016 : Akreditasi Paripurna

Desember 2016 : Penghargaan Rumah Sakit Trauma Center terbaik seMalang Raya Tahun 2016

April 2017 : Juara 1 Pelayanan dan Respon terbaik (Dinkes Kab. Malang)

Desember 2017 : Penghargaan Rumah Sakit Trauma Center terbaik seJawa Timur Tahun 2017

Pengembangan Gedung DPM

Desember 2017 : Menjadi tempat dokter internsip

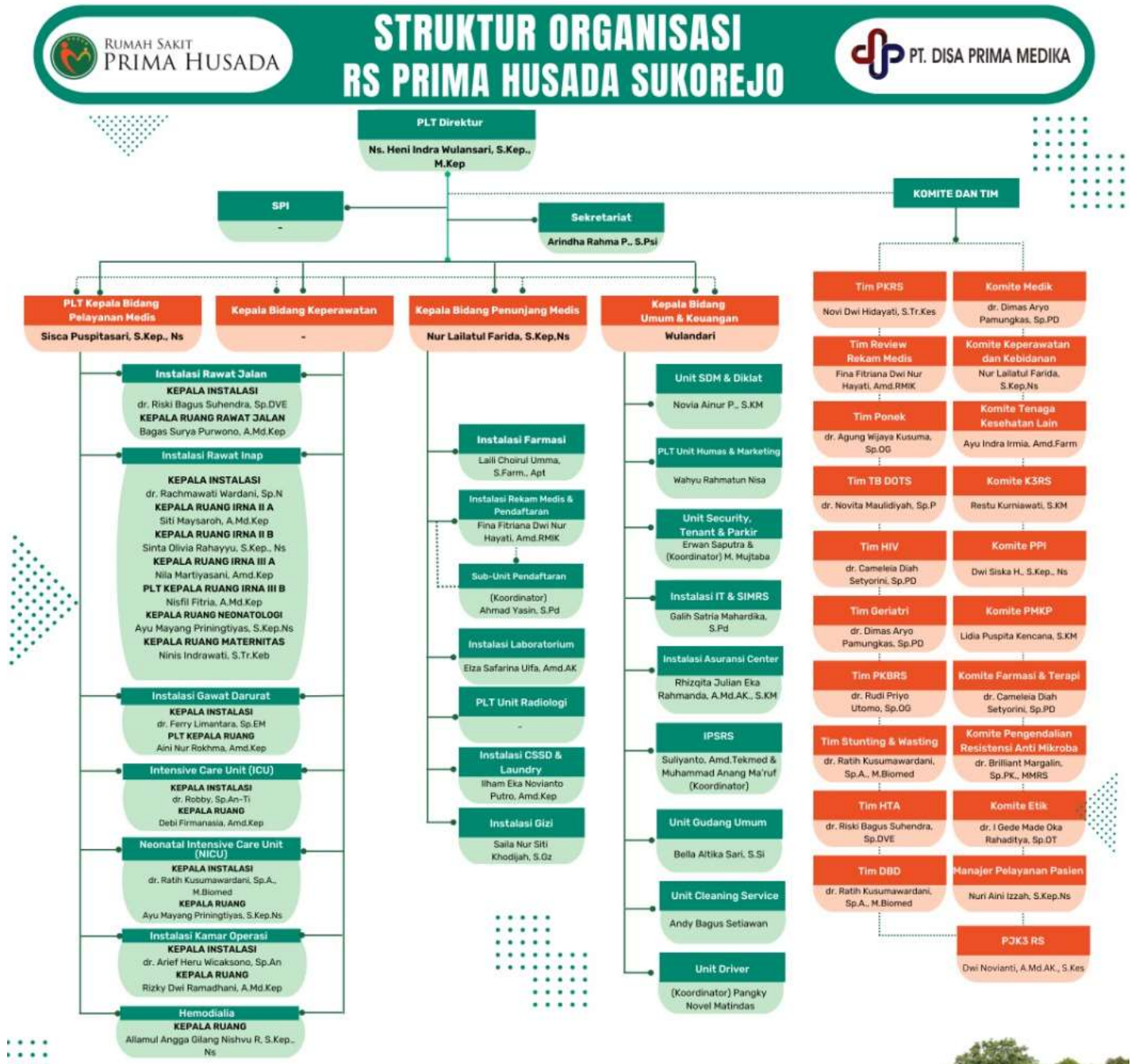
BAB III

VISI, MISI, NILAI BUDAYA, MOTO RS

- 3.1 **VISI**
“ Menjadi rumah sakit berkualitas prima pilihan seluruh lapisan masyarakat.”
- 3.2 **MISI**
Rumah Sakit Prima Husada memiliki misi :
1. Memberi pelayanan kesehatan dengan amat, tepat, cepat dan akurat
 2. Mengutamakan kepuasan pasien.
 3. Meningkatkan mutu pelayanan yang berkelanjutan.
- 3.3 **VALUE/NILAI/ 7 NILAI BUDI UTAMA**
Rumah Sakit Prima Husada memiliki Landasan 7 Nilai Budi Utama :
1. Jujur
 2. Tanggung Jawab
 3. Visioner
 4. Disiplin
 5. Kerjasama
 6. Adil
 7. Peduli
- 3.4 **MOTTO**
“Sahabat menuju sehat”

BAB IV STRUKTUR ORGANISASI UNIT KERJA

4.1 Bagan Organisasi



4.2 Keterangan

1. Unit Struktural

a. Direktur Rumah Sakit

Adalah kepala atau pejabat tertinggi di RS Prima Husada.

b. Kepala Bidang / Kepala Bagian

Adalah pejabat yang membantu Direktur dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan bidang masing-masing yaitu :

- 1) Kepala Bidang Pelayanan Medis membantu Direktur dalam bidang Pelayanan Rumah Sakit.
- 2) Kepala Bidang Penunjang Medis membantu Direktur dalam bidang Penunjang Rumah Sakit.
- 3) Kepala Bidang Operasional membantu Direktur dalam bagian :
 - a) SDM yang meliputi ketenagakerjaan, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia .
 - b) Keuangan dan Akutansi meliputi keuangan, akutansi dan pajak rumah sakit.
 - c) Umum meliputi : Saranan dan Prasarana Rumah Sakit, SIMRS, Rumah Tangga, Humas dan Pemasaran, Manajemen Kontrak, dan Pengaduan Pelayanan serta hubungan dengan pihak eksternal.

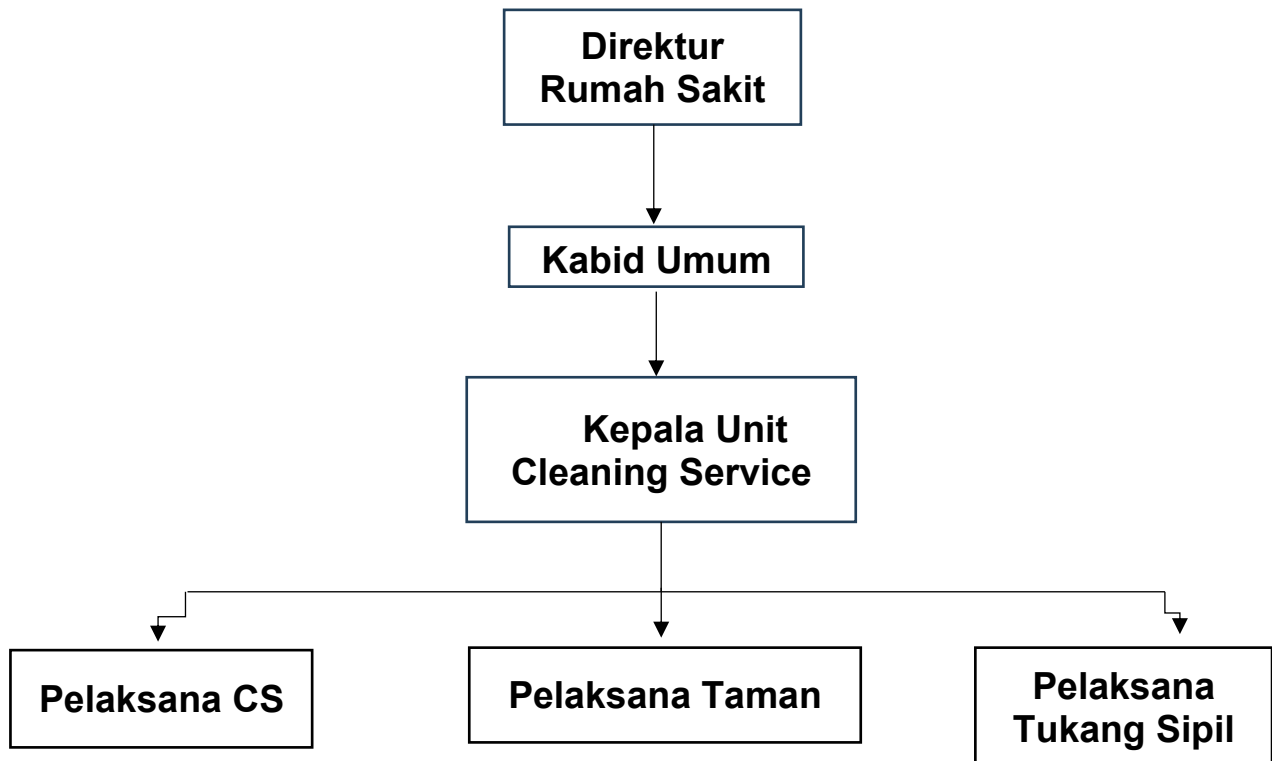


- c. Kepala Sub Bidang
Adalah pejabat yang membantu Kepala Bidang Pelayanan Medik dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan bidang masing-masing yaitu :
Sub Bidang Keperawatan membantu Kepala Bidang Pelayanan Medik dalam bidang Keperawatan.
 - d. Kepala Sub Bagian
Adalah pejabat yang membantu Kepala Bagian Operasional dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan bidang masing – masing yaitu :
 - 1) Sub Bagian SDM membantu Kepala Bagian Operasional dalam melaksanakan tugas terkait ketenagakerjaan Rumah Sakit
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Akutansi membantu Kepala Bagian Operasional dalam melaksanakan tugas terkait Keuangan dan Akutansi.
 - 3) Sub Bagian Umum membantu Kepala Bagian Operasional dalam melaksanakan tugas terkait Sarana Prasarana Rumah Sakit, SIMRS, Security, Cleaning Service, Humas dan Pemasaran, Manajemen Kontrak dan Pengaduan Pelayanan
 - e. Kepala Instalasi dan Kepala Unit
Adalah suatu wadah struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi dan memiliki fungsi tertentu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rumah sakit baik berfungsi pelayanan maupun pendukung operasional rumah sakit. Berikut adalah daftar kepala instalasi dan kepala bagian :
 - 1) Kepala Instalasi Rawat Jalan
 - 2) Kepala Instalasi Rawat Inap
 - 3) Kepala Intensive Care Unit
 - 4) Kepala Instalasi Gawat Darurat
 - 5) Kepala Instalasi Kamar Operasi
 - 6) Kepala Instalasi Farmasi
 - 7) Kepala Instalasi Rekam Medis
 - 8) Kepala Unit Hemodialisa
 - 9) Kepala Unit Laboratorium
 - 10) Kepala Unit Radiologi
 - 11) Kepala Unit Gizi
 - 12) Kepala Unit Laundry
 - 13) Kepala Unit Kamar Jenazah
 - 14) Kepala Unit Fisioterapi
 - 15) Kepala Bagian SDM
 - 16) Kepala Bagian Keuangan dan Akutansi
 - 17) Kepala Bagian Umum
2. Unit Non Struktural
Adalah wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli dan profesi dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada direktur dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan rumah sakit. Komite/ Panitia / Tim yang ada di Rumah Sakit Prima Husada adalah sebagai berikut:
- a. Komite Medik
 - b. Komite Keperawatan
 - c. Komite Tenaga Kesehatan Lain
 - d. Komite K3RS
 - e. Komite PPI
 - f. Komite PMKP
 - g. Komite Farmasi & Terapi
 - h. Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba
 - i. Komite Etik
 - j. Manajer Pelayanan Pasien
 - k. Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3)
 - l. Tim Review Rekam Medis
 - m. Tim TB DOTS
 - n. Tim PONEK
 - o. Tim Geriatri
 - p. Tim PKBRS
 - q. Tim HIV
 - r. Tim PKRS
 - s. Tim Stunting dan wasting
 - t. Tim HTA
 - u. Tim DBD

BAB V

URAIAN JABATAN

5.1 Struktur Organisasi Unit *Cleaning Service*



5.2 Uraian Jabatan

5.2.1 Direktur

1. Tugas

- Memimpin penyelenggaraan pelayanan rumah sakit secara keseluruhan.
- Menetapkan kebijakan dan strategi pelayanan rumah sakit.
- Mengawasi seluruh kegiatan operasional rumah sakit.
- Menjamin terselenggaranya pelayanan yang bermutu, aman, efektif, dan efisien.
- Menetapkan kebijakan terkait kebersihan lingkungan dan pelayanan penunjang rumah sakit.
- Mendukung pelaksanaan program PPI, K3RS, mutu, dan keselamatan pasien.
- Menyetujui program kerja dan kebutuhan anggaran unit kerja.
- Melakukan evaluasi terhadap kinerja seluruh bidang dan unit rumah sakit.
- Menjalin koordinasi dengan pihak internal dan eksternal rumah sakit.
- Memastikan rumah sakit memenuhi standar akreditasi dan regulasi yang berlaku.

2. Wewenang

- Menetapkan kebijakan dan keputusan rumah sakit.
- Mengangkat, memindahkan, dan mengevaluasi pejabat struktural sesuai ketentuan.
- Menyetujui kebutuhan anggaran operasional rumah sakit.
- Memberikan arahan kepada seluruh bidang dan unit kerja.
- Menentukan prioritas pengembangan pelayanan rumah sakit.
- Mengambil keputusan strategis dalam operasional rumah sakit.

3. Tanggungjawab

- Bertanggung jawab terhadap seluruh penyelenggaraan pelayanan rumah sakit.
- Bertanggung jawab terhadap mutu pelayanan dan keselamatan pasien.
- Bertanggung jawab terhadap pemenuhan standar akreditasi rumah sakit.
- Bertanggung jawab terhadap pengelolaan sumber daya rumah sakit.
- Bertanggung jawab terhadap pencapaian visi, misi, dan tujuan rumah sakit.
- Bertanggung jawab kepada pemilik rumah sakit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.2.2 Kabid Umum

1. Tugas

- Mengkoordinasikan seluruh pelayanan penunjang umum rumah sakit.



- b. Mengawasi pelaksanaan kegiatan unit cleaning service, keamanan, taman, laundry, driver, dan sarana umum lainnya sesuai struktur organisasi rumah sakit.
- c. Menyusun kebijakan teknis pelayanan umum rumah sakit.
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi pelayanan unit di bawah koordinasinya.
- e. Berkoordinasi dengan manajemen rumah sakit terkait kebutuhan operasional sarana umum.
- f. Mengawasi pemeliharaan kebersihan, kenyamanan, dan keamanan lingkungan rumah sakit.
- g. Memastikan seluruh kegiatan pelayanan umum berjalan sesuai standar akreditasi rumah sakit dan regulasi yang berlaku.
- h. Membina kepala unit di bawah bidang umum.
- i. Menyusun laporan kegiatan bidang umum kepada direktur rumah sakit.
- j. Mendukung program PPI, K3RS, mutu, dan keselamatan pasien di lingkungan rumah sakit.

2. Wewenang

- a. Memberikan arahan dan instruksi kepada kepala unit di bawah bidang umum.
- b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan umum rumah sakit.
- c. Mengusulkan kebutuhan SDM, sarana, dan prasarana bidang umum.
- d. Memberikan evaluasi kinerja kepala unit dan petugas di bawah koordinasinya.
- e. Mengambil tindakan operasional terkait pelayanan umum dalam kondisi tertentu.
- f. Mengusulkan pengadaan alat dan bahan operasional kepada manajemen.

3. Tanggungjawab

- a. Bertanggung jawab terhadap kelancaran pelayanan umum rumah sakit.
- b. Bertanggung jawab terhadap kebersihan, kenyamanan, dan keamanan lingkungan rumah sakit.
- c. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program kerja bidang umum.
- d. Bertanggung jawab terhadap pembinaan SDM di bawah bidang umum.
- e. Bertanggung jawab terhadap pelaporan kegiatan bidang umum kepada direktur rumah sakit.

5.2.3 Kepala Unit

1. Tugas

- a. Menyusun perencanaan kegiatan kebersihan lingkungan rumah sakit.
- b. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan pelayanan cleaning service.
- c. Mengawasi pelaksanaan kebersihan area pelayanan, non pelayanan, taman, dan sarana umum rumah sakit.
- d. Membuat jadwal kerja petugas cleaning service, petugas taman, dan tukang sipil.
- e. Melakukan monitoring penggunaan bahan dan alat kebersihan.
- f. Melakukan evaluasi kebersihan lingkungan secara berkala.
- g. Berkoordinasi dengan Komite PPI terkait standar kebersihan dan desinfeksi lingkungan.
- h. Melakukan pembinaan dan edukasi kepada seluruh petugas unit.
- i. Membuat laporan kegiatan unit cleaning service kepada Kabid Umum.
- j. Memastikan pelayanan kebersihan berjalan sesuai standar akreditasi rumah sakit.

2. Wewenang

- a. Memberikan instruksi kerja kepada seluruh petugas unit cleaning service.
- b. Mengatur pembagian tugas dan jadwal kerja petugas.
- c. Mengusulkan kebutuhan alat, bahan, dan SDM cleaning service.
- d. Menegur petugas yang tidak melaksanakan tugas sesuai SOP.
- e. Menghentikan penggunaan alat yang tidak layak pakai.
- f. Mengusulkan pelatihan petugas cleaning service.
- g. Berkoordinasi dengan unit terkait dalam penanganan kebersihan lingkungan.

3. Tanggungjawab

- a. Bertanggung jawab terhadap kebersihan dan kenyamanan lingkungan rumah sakit.
- b. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan SOP kebersihan.
- c. Bertanggung jawab terhadap keselamatan kerja petugas cleaning service.
- d. Bertanggung jawab terhadap penggunaan bahan kimia dan alat kebersihan.
- e. Bertanggung jawab terhadap pelaporan kegiatan unit.
- f. Bertanggung jawab terhadap pencapaian indikator mutu unit cleaning service.

5.2.4 Pelaksana CS

1. Tugas



- a. Melaksanakan pembersihan area rumah sakit sesuai jadwal dan SOP.
 - b. Membersihkan lantai, dinding, kaca, toilet, dan peralatan lingkungan.
 - c. Melakukan desinfeksi permukaan di area pelayanan.
 - d. Mengelola sampah sesuai jenis dan warna kantong limbah.
 - e. Menggunakan APD sesuai risiko kerja.
 - f. Menjaga kebersihan area rawat inap, rawat jalan, kantor, dan area umum.
 - g. Melaporkan kerusakan sarana kepada atasan.
 - h. Menjaga kebersihan alat kerja setelah digunakan.
 - i. Membantu pelaksanaan kebersihan terminal cleaning bila diperlukan.
 - j. Mematuhi ketentuan PPI dan K3RS.
2. Wewenang
 - a. Menggunakan alat dan bahan kebersihan sesuai kebutuhan kerja.
 - b. Meminta penggantian alat yang rusak.
 - c. Melaporkan kondisi lingkungan yang berisiko infeksi atau kecelakaan kerja.
 - d. Menolak penggunaan bahan berbahaya tanpa APD lengkap.
 3. Tanggungjawab
 - a. Bertanggung jawab terhadap kebersihan area kerja masing-masing.
 - b. Bertanggung jawab terhadap penggunaan alat dan bahan kebersihan.
 - c. Bertanggung jawab terhadap kepatuhan penggunaan APD.
 - d. Bertanggung jawab terhadap pemilahan sampah sesuai ketentuan.
 - e. Bertanggung jawab menjaga keselamatan kerja selama bertugas.

5.2.5 Pelaksana Taman

1. Tugas
 - a. Melakukan perawatan taman dan penghijauan rumah sakit.
 - b. Menyiram tanaman secara rutin.
 - c. Membersihkan area taman dari sampah dan daun kering.
 - d. Melakukan pemangkasan tanaman.
 - e. Menjaga kebersihan saluran air di area taman.
 - f. Menggunakan alat kerja sesuai prosedur keselamatan.
2. Wewenang
 - a. Menggunakan peralatan perawatan taman.
 - b. Mengusulkan penggantian tanaman yang rusak.
 - c. Melaporkan kerusakan fasilitas taman.
3. Tanggungjawab
 - a. Bertanggung jawab terhadap kebersihan dan keindahan taman.
 - b. Bertanggung jawab terhadap penggunaan alat kerja taman.
 - c. Bertanggung jawab terhadap keselamatan kerja selama bekerja.

5.2.6 Pelaksana Tukang Sipil

1. Tugas
 - a. Melakukan perbaikan ringan sarana dan prasarana rumah sakit.
 - b. Melaksanakan pekerjaan sipil sederhana seperti pengecatan, perbaikan dinding, lantai, dan plafon.
 - c. Memastikan area kerja aman selama proses perbaikan.
 - d. Membantu pemeliharaan fasilitas gedung rumah sakit.
 - e. Melaporkan kerusakan bangunan kepada atasan.
2. Wewenang
 - a. Menggunakan alat kerja sipil sesuai kebutuhan.
 - b. Mengusulkan kebutuhan material perbaikan.
 - c. Menghentikan pekerjaan apabila kondisi membahayakan keselamatan.
3. Tanggungjawab
 - a. Bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaan perbaikan.
 - b. Bertanggung jawab terhadap penggunaan alat dan material kerja.
 - c. Bertanggung jawab terhadap keselamatan kerja dan kebersihan area kerja.
 - d. Bertanggung jawab menjaga fasilitas rumah sakit selama proses pekerjaan berlangsung.



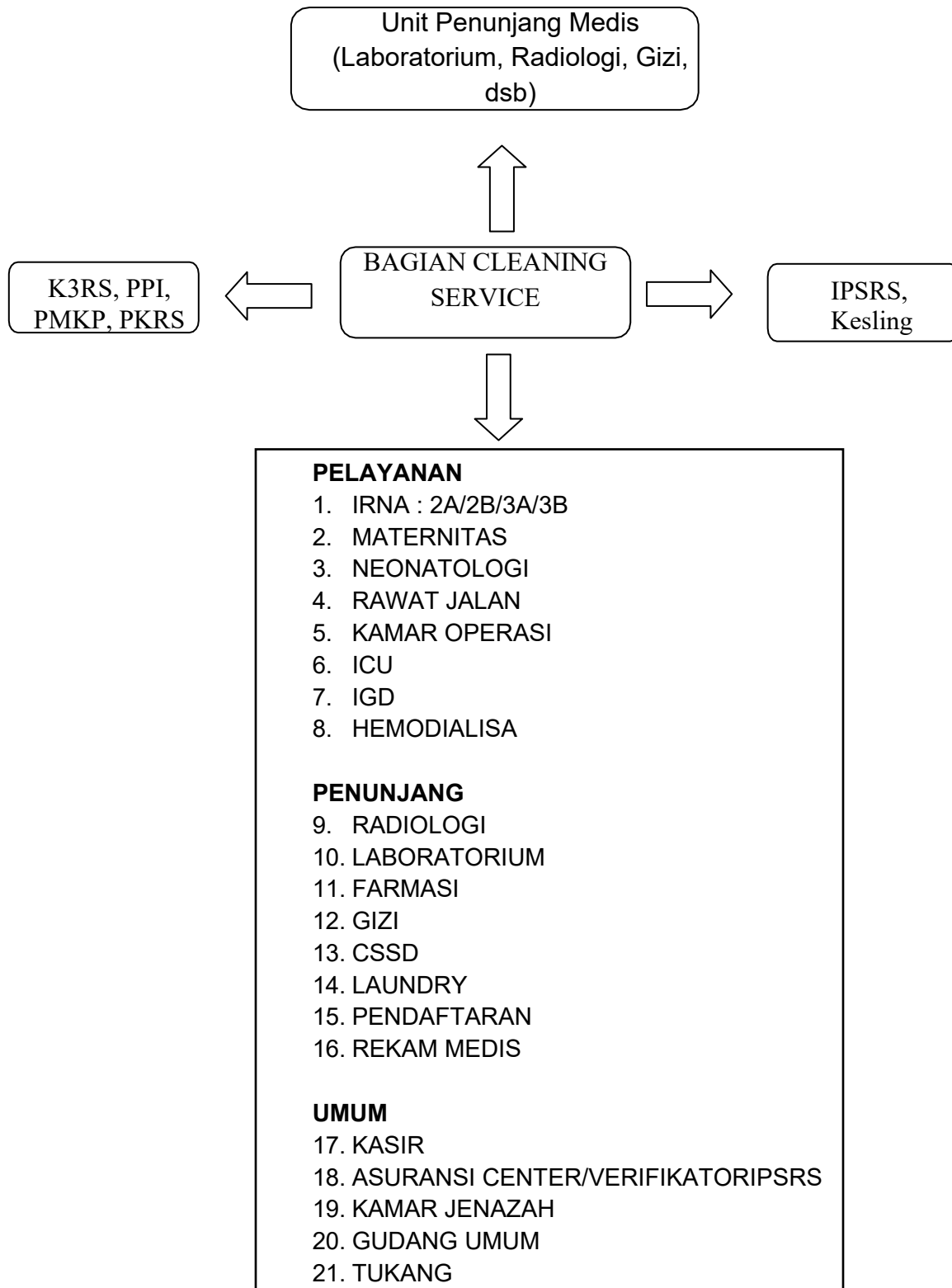
RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA



PT. DISA PRIMA MEDIKA

BAB VI TATA HUBUNGAN KERJA

7.1 Tata Hubungan Kerja



7.2 Tata

1. Tata hubungan kerja sub bagian Cleaning Service dengan bagian Unit Penunjang Medis:
Sub Bagian Cleaning Service berkoordinasi dengan seluruh unit penunjang medis dalam menjaga kebersihan, sanitasi, dan kenyamanan lingkungan kerja guna mendukung mutu pelayanan kesehatan serta mencegah terjadinya infeksi terkait pelayanan kesehatan (HAIs).
Bentuk Koordinasi:
 - a. Melaksanakan pembersihan rutin dan berkala pada area pelayanan medis dan penunjang medis.
 - b. Menindaklanjuti permintaan pembersihan khusus dari unit terkait.
 - c. Melakukan penanganan tumpahan cairan tubuh, darah, dan bahan infeksius sesuai prosedur PPI.
 - d. Menjaga kebersihan fasilitas, peralatan non-medis, dan lingkungan kerja.
 - e. Melaporkan kondisi lingkungan yang berpotensi menimbulkan risiko keselamatan atau infeksi.
2. Tata hubungan kerja sub bagian Cleaning Service dengan bagian K3RS, PPI, PMKP:
 - a. Tim K3RS (Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit)
Cleaning Service berkoordinasi dalam upaya menciptakan lingkungan kerja yang aman bagi pasien, pengunjung, dan petugas.
Bentuk Koordinasi:
 - 1) Penggunaan APD sesuai risiko pekerjaan.
 - 2) Penanganan limbah sesuai ketentuan keselamatan kerja.
 - 3) Pelaporan kejadian kecelakaan kerja dan kondisi tidak aman.
 - 4) Pelaksanaan program keselamatan lingkungan rumah sakit.
 - 5) Kesiapsiagaan terhadap keadaan darurat dan bencana.
 - b. Tim PPI (Pencegahan dan Pengendalian Infeksi)
Cleaning Service merupakan bagian penting dalam pelaksanaan program PPI rumah sakit.
Bentuk Koordinasi:
 - 1) Melaksanakan pembersihan dan desinfeksi lingkungan sesuai standar PPI.
 - 2) Mengikuti pelatihan PPI yang diselenggarakan rumah sakit.
 - 3) Melaksanakan kewaspadaan standar dan transmisi.
 - 4) Menggunakan bahan desinfektan sesuai rekomendasi PPI.
 - 5) Melaporkan kejadian paparan darah atau cairan tubuh.
 - c. Tim PMKP (Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien)
Bentuk Koordinasi:
 - 1) Mendukung pencapaian indikator mutu kebersihan lingkungan.
 - 2) Mengikuti audit mutu dan survei kepatuhan kebersihan.
 - 3) Melaksanakan tindak lanjut hasil evaluasi mutu.
 - 4) Berpartisipasi dalam kegiatan peningkatan mutu pelayanan.
3. Tata hubungan kerja sub bagian Cleaning Service dengan bagian IPSRS, Kesling
 - a. IPSRS (Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit)
Bentuk Koordinasi:
 - 1) Melaporkan kerusakan sarana dan prasarana.
 - 2) Berkoordinasi dalam perbaikan fasilitas yang mempengaruhi kebersihan lingkungan.
 - 3) Mendukung kegiatan renovasi atau pemeliharaan gedung.
 - 4) Melaksanakan pembersihan pasca perbaikan atau konstruksi.
 - b. Unit Kesehatan Lingkungan (Kesling)
Bentuk Koordinasi:
 - 1) Pengelolaan kebersihan lingkungan rumah sakit.
 - 2) Pengendalian vektor dan binatang pengganggu.
 - 3) Pengelolaan limbah domestik.
 - 4) Pemantauan sanitasi lingkungan rumah sakit.
 - 5) Pelaksanaan program kebersihan dan penghijauan lingkungan.



4. Tata hubungan kerja sub bagian Cleaning Service dengan unit pelayanan (IRNA, IRJA, IKO, IGD, ICU, HD, RADIOLOGI, LABORATORIUM, FARMASI, REKAM MEDIS, PENDFTARAN, GIZI, ASURANSI CENTER/VERIFIKATOR, IPSRS, KAMAR JENZAH GUDANG UMUM):
- a. Rawat Inap (IRNA)
 - 1) Melakukan pembersihan ruang perawatan sesuai jadwal.
 - 2) Melakukan terminal cleaning setelah pasien pulang, pindah, atau meninggal.
 - 3) Menangani tumpahan cairan tubuh sesuai prosedur.
 - b. Rawat Jalan (IRJA)
 - 1) Menjaga kebersihan ruang tunggu, poli, dan fasilitas umum.
 - 2) Melakukan pembersihan sebelum dan sesudah pelayanan.
 - c. Instalasi Kamar Operasi (IKO)
 - 1) Melaksanakan cleaning antar tindakan (between case cleaning).
 - 2) Melaksanakan terminal cleaning harian dan berkala.
 - 3) Mengikuti prosedur aseptik yang berlaku.
 - d. Instalasi Gawat Darurat (IGD)
 - 1) Menjaga kebersihan area pelayanan 24 jam.
 - 2) Melakukan pembersihan segera setelah tindakan emergensi.
 - e. ICU
 - 1) Melaksanakan pembersihan dengan prinsip kewaspadaan infeksi yang ketat.
 - 2) Menggunakan APD sesuai ketentuan.
 - f. Hemodialisa (HD)
 - 1) Melaksanakan pembersihan area tindakan dan ruang tunggu.
 - 2) Menangani tumpahan darah sesuai standar PPI.
 - g. Radiologi
 - 1) Menjaga kebersihan ruang pemeriksaan dan ruang tunggu pasien.
 - 2) Berkoordinasi terkait jadwal pembersihan alat dan ruangan.
 - h. Laboratorium
 - 1) Melakukan pembersihan area kerja non-peralatan medis.
 - 2) Berkoordinasi dalam penanganan bahan infeksius yang tumpah.
 - i. Farmasi
 - 1) Menjaga kebersihan area pelayanan dan penyimpanan obat.
 - 2) Memastikan lingkungan bebas debu dan kotoran.
 - j. Rekam Medis dan Pendaftaran
 - 1) Menjaga kebersihan ruang kerja dan area pelayanan pasien.
 - 2) Mendukung kenyamanan petugas dan pengunjung.
 - k. Instalasi Gizi
 - 1) Melaksanakan pembersihan area pengolahan makanan sesuai standar sanitasi.
 - 2) Berkoordinasi terkait jadwal pembersihan khusus.
 - l. Asuransi Center/Verifikator
Menjaga kebersihan ruang administrasi dan pelayanan pelanggan.
 - m. Kamar Jenazah
 - 1) Melaksanakan pembersihan dan desinfeksi sesuai prosedur PPI.
 - 2) Menggunakan APD lengkap saat bertugas.
 - n. Gudang Umum
 - 1) Menjaga kebersihan area penyimpanan barang.
 - 2) Mengendalikan debu, hama, dan kondisi lingkungan gudang.
 - 3) Mekanisme Pelaporan dan Koordinasi
 - 4) Permintaan layanan kebersihan disampaikan oleh unit terkait kepada Koordinator Cleaning Service.
 - 5) Koordinator Cleaning Service mengatur penugasan petugas sesuai kebutuhan.
 - 6) Hasil pelaksanaan pekerjaan didokumentasikan dalam checklist atau logbook kebersihan.
 - 7) Temuan terkait kerusakan sarana, risiko infeksi, atau keselamatan kerja dilaporkan kepada unit terkait untuk tindak lanjut.
 - 8) Evaluasi koordinasi dilakukan secara berkala melalui rapat koordinasi lintas unit
 - 9) Dokumen ini dapat dijadikan Lampiran Pedoman Tata Hubungan Kerja Cleaning Service Rumah Sakit sesuai Standar Akreditasi

BAB VII
POLA KETENAGAAN DAN KUALIFIKASI PERSONIL

Tabel 8.1 Pola Ketenagaan Dan Kualifikasi Personil

No	Nama Jabatan	Jumlah SDM				Kualifikasi					
						Pendidikan			Sertifikasi		
		Standar	Kondisi Saat Ini	Kebutuhan	Perencanaan	Standar	Kondisi Saat Ini	Kebutuhan	Standar	Kondisi Saat Ini	Kebutuhan
1	Ka. Bagian Cleaning Service	1	1	0	Dipertahankan	SMA/D3 Kesehatan / Manajemen RS	SMA/SMK	-	Pelatihan Manajemen Cleaning Service, K3 dan PPI dasar	Sudah in house training	Pelatihan manajemen Cleaning Service eksternal dan PPI Dasar
2	PJ Cleaning Service	8	8	0	Dipertahankan	SMA/SMK	SMA/SMK	-	Pelatihan Manajemen Cleaning Service, K3 dan PPI dasar	Sudah in house training	Perlu update ilmu
3	Anggota Cleaning Service	43	43	0	Dipertahankan	SMA/SMK	SMA/SMK	-	Pelatihan PPI Dasar dan K3	Sudah in house training	Perlu update ilmu

BAB VIII

PROGRAM ORIENTASI

9.1 Orientasi Umum Rumah Sakit

Orientasi umum rumah sakit merupakan kegiatan pengenalan bagi pegawai baru untuk memahami kebijakan, sistem kerja, serta budaya kerja di Rumah Sakit Prima Husada. Tujuan orientasi umum:

1. Memberikan pemahaman kepada pegawai baru mengenai visi, misi, dan nilai rumah sakit.
2. Mengenalkan struktur organisasi dan sistem pelayanan rumah sakit.
3. Memberikan pemahaman tentang kebijakan, peraturan, serta budaya kerja rumah sakit.
4. Meningkatkan kesiapan pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai standar yang berlaku.

Materi orientasi umum rumah sakit meliputi:

1. Profil Rumah Sakit Prima Husada.
2. Visi, misi, motto, dan nilai-nilai rumah sakit.
3. Struktur organisasi rumah sakit.
4. Peraturan dan tata tertib pegawai.
5. Program mutu dan keselamatan pasien.
6. Program Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI).
7. Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja Rumah Sakit (K3RS).
8. Etika pelayanan dan komunikasi efektif.
9. BHD

Penilaian orientasi umum dilakukan melalui:

1. Kehadiran peserta orientasi.
2. Evaluasi pemahaman materi melalui pre-test dan post-test.
3. Observasi sikap dan partisipasi peserta selama kegiatan orientasi.

9.2 Orientasi Khusus Di Unit

Orientasi unit merupakan kegiatan pengenalan bagi pegawai baru yang ditempatkan di Unit Cleaning Service agar memahami tugas, tanggung jawab, serta prosedur kerja di unit tersebut dengan tujuan meliputi:

2. Memberikan pemahaman mengenai tugas dan fungsi Unit Cleaning Service.
3. Mengenalkan alur kerja pengelolaan kebersihan dan limbah di rumah sakit.
4. Meningkatkan kemampuan petugas dalam menjalankan tugas sesuai prosedur yang berlaku.

Materi orientasi unit Cleaning Service meliputi:

1. Struktur organisasi Unit Cleaning Service.
2. Tugas dan tanggung jawab petugas Cleaning Service.
3. Alur pengelolaan limbah dan kebersihan rumah sakit.
4. Prosedur pengambilan limbah dari unit pelayanan dan pembersihan lingkungan.
5. Penggunaan alat pelindung diri (APD).
6. Pencegahan dan pengendalian infeksi dalam pengelolaan lingkungan.
7. Keselamatan kerja di Unit Cleaning Service.

Jadwal orientasi unit dilaksanakan selama $\pm$ 1-3 hari kerja atau disesuaikan dengan kebutuhan unit. Penilaian orientasi unit dilakukan melalui:

1. Observasi langsung oleh kepala unit Cleaning Service.
2. Evaluasi pemahaman prosedur kerja.
3. Kemampuan petugas dalam melaksanakan tugas sesuai SOP.



BAB IX PERTEMUAN / RAPAT

Rapat berkala terdiri dari :

1. Rapat Rutin

a. Rapat Koordinasi

Waktu : Menyesuaikan Direksi
Jam : Menyesuaikan Direksi
Tempat : Hall Sakura RS Prima Husada
Peserta : Direktur RS, Kabid. Yanmed, Kabid. Penmed, kabid Umum, Ka. Unit Cleaning Service, Kabag. Umum, Kepala Instalasi, Kepala, Kepala Unit/Ruang lainnya.
Materi : Pembahasan permasalahan berkaitan dengan pelayanan.

b. Rapat Satuan Kerja

Waktu : Setiap Kamis
Jam : Menyesuaikan
Tempat : Ruang Cleaning Service/Hall pertemuan/Online
Peserta : Ka. Bagian Cleaning Service dan anggota
Materi : Permasalahan dan Pembahasan di Bagian Cleaning Service

Rapat Insidentil diselenggarakan sewaktu – waktu bila ada masalah atau sesuatu hal yang perlu dibahas segera.

BAB X PELAPORAN

Pelaporan Kegiatan Unit Cleaning Service meliputi:

1. Laporan Harian
Berisi pencatatan kegiatan kebersihan dan sanitasi lingkungan, penggunaan alat dan bahan, serta kondisi kebersihan area pelayanan dan non pelayanan.
2. Laporan Bulanan
Berisi rekapitulasi kegiatan Cleaning Service selama satu bulan, meliputi capaian kebersihan lingkungan, penggunaan bahan dan alat, kepatuhan petugas terhadap prosedur, serta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pelayanan.
3. Laporan Isidentil
Laporan yang dibuat apabila terjadi kejadian tertentu yang berkaitan dengan pelayanan Cleaning Service, seperti kecelakaan kerja, paparan bahan berbahaya, kerusakan alat, kejadian infeksi terkait lingkungan, atau kejadian tidak diharapkan lainnya.

Mekanisme pelaporan di Unit Cleaning Service dilakukan melalui pencatatan kegiatan operasional setiap hari oleh petugas, yang kemudian direkapitulasi secara berkala oleh penanggung jawab Cleaning Service. Laporan kegiatan disampaikan kepada atasan langsung (Kepala Bagian Umum/Kabid terkait) secara berjenjang. Hasil pelaporan digunakan sebagai bahan monitoring dan evaluasi dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kebersihan lingkungan Rumah Sakit.

Evaluasi pelaporan dilakukan secara berkala untuk menilai:

- Tingkat kebersihan lingkungan Rumah Sakit;
- Ketepatan dan konsistensi pelaksanaan kegiatan cleaning service;
- Kepatuhan petugas terhadap SPO, PPI, dan K3RS;
- Ketersediaan sarana, prasarana, dan bahan kebersihan;
- Permasalahan yang terjadi serta tindak lanjut perbaikan.

Dengan adanya pedoman ini, diharapkan pelaksanaan kegiatan Cleaning Service di Rumah Sakit dapat berjalan secara efektif, efisien, aman, serta mendukung upaya peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.

BAB XI PENUTUP

Pedoman Pengorganisasian Unit Cleaning Service Rumah Sakit Prima Husada ini disusun sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan kebersihan, sanitasi lingkungan, dan pengelolaan lingkungan rumah sakit agar dapat berjalan secara terarah, terkoordinasi, dan sesuai dengan standar yang berlaku.

Dengan adanya pedoman ini diharapkan seluruh petugas yang terlibat dalam kegiatan Cleaning Service dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif, efisien, serta memperhatikan prinsip keselamatan kerja dan pencegahan serta pengendalian infeksi di rumah sakit.

Pedoman ini akan dilakukan peninjauan dan evaluasi secara berkala sesuai dengan perkembangan kebijakan, peraturan perundang-undangan, serta kebutuhan pelayanan rumah sakit guna meningkatkan mutu pelayanan Unit Cleaning Service Rumah Sakit Prima Husada.

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 01 November 2025
Direktur Rumah Sakit Prima Husada,



Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep., M.Kep